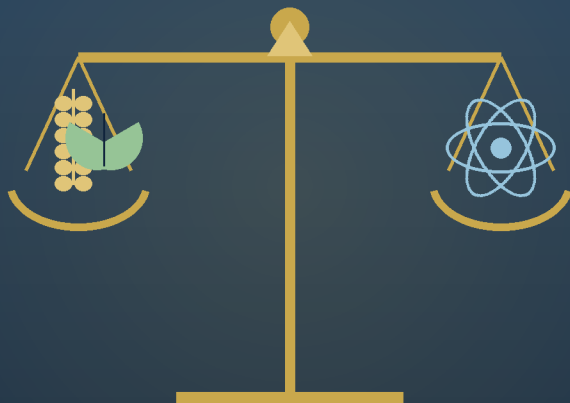




نظام الطيبات في ميزان العلم

قراءة علمية نقدية في ضوء الطب المبني على البراهين
والمفهوم القرآني للطيبات

The Tayyibat Diet on the Scale of Science

A Critical, Evidence-Based Evaluation

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Al-Akwa'a

Arabic & English |

عربي - إنجليزي

2026

نظام الطيبات في ميزان العلم

قراءة علمية نقدية في ضوء الطب المبني على البراهين
والمفهوم القرآني للطيبات

The Tayyibat Diet on the Scale of Science

A Critical, Evidence-Based Evaluation

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Al-Akwa'a

الطبعة الأولى — 2026م

First Edition — 2026

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

All Rights Reserved to the Author

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا﴾

الإهداء

إلى كلّ باحثٍ عن الحقيقة لا يقنعُ بالشائع حتى يزنه بميزان البرهان،
وإلى كلّ من آمن أنّ نعم الله طيّبات لا تُحرّم بهوى، ولا تُستباح
بإسراف،

وإلى من علّمونا أنّ الاعتدال سنة الخلق وطريق العافية،

إلى رُوح والدي رحمه الله، وإلى أمي حفظها الله،
وإلى زوجتي وأولادي، وإخواني وأخواتي،

أهدي هذا الكتاب؛ رجاء أن يكون قولاً طيباً في ميزانٍ طيب.

المحتويات

7	مقدمة الكتاب
9	الفصل الأول: ما هو «نظام الطيبات»؟ النشأة والفكرة والقواعد
13	الفصل الثاني: المفهوم القرآني للطيبات — الطيب والخبيث في ميزان الوحي
17	الفصل الثالث: كيف نزن نظاماً غذائياً؟ مبادئ الطب المبني على البراهين
21	الفصل الرابع: البقوليات والحبوب الكاملة — حذف ركائز أثبت العلم نفعها
25	الفصل الخامس: البيض والألبان والدواجن — مجموعات محذوفة بلا دليل
28	الفصل السادس: الخضراوات والفواكه — حين يُمنع أنفع الطعام
31	الفصل السابع: الدهون والسعرات — الإباحة المطلقة في مواجهة توصيات القلب
34	الفصل الثامن: الماء والعطش والصيام المتقطع — قواعد تحتاج إلى تحفظ
36	الفصل التاسع: الأطعمة فائقة المعالجة والسكر — حيث يلتقي النظام مع العلم جزئياً
39	الفصل العاشر: دعوى علاج الأمراض المزمنة — أين الدليل؟
42	الفصل الحادي عشر: خلاصة الميزان — نحو نمط غذائي متوازن
45	الخاتمة
46	المراجع العلمية (مصنفة)
48	The English Translation
77	نبذة عن المؤلف — About the Author

مقدمة الكتاب

بين اسمِ قرآنِي كَرِيمٍ، وميزانِ علمِي دَقِيقٍ

قلَّ أن يجتمعَ في موضوعٍ واحدٍ ما اجتمعَ في «نظام الطِّبِّيات»: اسمُ قرآنِي مهيبٌ يَسْتَدْعِي في النفسَ معاني الحِلِّ والطَّهرِ والبركةِ، ودعوى طَبيَّةٌ واسعةٌ تُعَدُّ بالشفاءِ من أمراضٍ مزمنةٍ عجزتَ عنها العياداتُ والمستشفياتُ، وانتشارٌ جارِفٌ عبر منصَّاتِ التواصلِ حوْلَ قوائمِ «المسموح» و«الممنوع» إلى ما يشبه العقيدةَ الغذائية عند كثيرٍ من الناس. ثم جاء رَحيلُ صاحبِ النظامِ المفاجئِ لِيُشْعِلَ الجدلَ من جديدٍ، ويعيدَ السؤالَ إلى أصله: ما الذي يَقولُه العلمُ — حقًّا لا ادِّعاءً — عن هذا النظامِ؟ وما الذي يَقولُه الوحيُّ عن الكلمةِ التي استعارها النظامُ عنوانًا لنفسه؟

هذا الكتابُ ليس خصومةً مع شخصٍ، ولا انتصارًا لمدرسةٍ على أخرى، ولا دفاعًا عن صناعةٍ غذائيةٍ بعينها. هو محاولةٌ منضبطةٌ لَوْزَنِ دعوى غذائيةٍ شاعتَ بين الناسِ على ميزانينِ اثنينِ لا ثالثَ لهما عند المسلمِ الباحثِ: ميزانِ الوحيِ الذي أنزلَ كلمةَ «الطِّبِّياتِ» وبينَ مرادهِ منها، وميزانِ العلمِ الذي راكمَ على مدى عقودٍ أدلةً عن علاقةِ الغذاءِ بالصحةِ. ودعوى تزعمُ لنفسها سندًا من القرآنِ ومن الطبِّ جميعًا، حقيقٌ بأن تُوزَنَ بهما جميعًا.

وستظهرُ — بإذنِ الله — مفارقةٌ لافتةٌ تتكرَّرُ في فصولِ الكتابِ: أنَّ المفهومَ القرآنيَّ للطِّبِّياتِ مفهومٌ جامعٌ مُبيحٌ مُيسِّرٌ، يأمرُ بالأكلِ من كلِّ حلالٍ طَيِّبٍ ويُكرِّهُ على الغُلَّةِ

الذين يُحَرِّمون ما أحلَّ الله؛ بينما «نظامُ الطِّيبات» الدارجُ يَقْلِبُ هذا المعنى فَيَنِي سلطانه على المنع والتَّحريم حتى حَرَّمَ على الناس مجموعات غذائيةً كاملةً سَمَّاهَا اللهُ في كتابه طِيبَات. فبين الاسم ومُسمَّاه مسافةٌ يكشفُها التَّأمُّلُ، ويزيدها العلمُ الحديثُ وضوحاً.

رَبَّتُ الْكِتَابَ فِي أَحَدِ عَشَرَ فَصْلاً: أبدأُ بتعريفِ النظامِ كما طرحه صاحبه دون تحريفٍ ولا تهوين، ثم أُحرِّرُ المعنى القرآنيَّ للطِّيبَات من كتب التفسيرِ المعتمدة، ثم أضعُ بين يدي القارئ «مِسطرةً» علميةً يوزُنُ بها أيُّ نظامٍ غذائيٍّ قبل أن يُؤخَذَ بالتسليم. وبعدها أمضي إلى تفاصيلِ النظامِ مجموعةٌ مجموعةٌ: البقولياتِ المحذوفةُ، والبيضُ والألبانُ والدواجنُ الممنوعةُ، والخضراواتِ والفواكهُ المُقَصَّاةُ، والدهونُ والسعراتُ المُطلَقةُ، وقواعدُ الماءِ والصيامِ، ثم نقطةُ الالتقاءِ الجزئيِّ مع العلمِ في مسألةِ الأُطعمةِ فائقةِ المعالجةِ، فدعوى علاجِ الأمراضِ المزمنةِ. وأختمُ بميزانٍ منصفٍ يَجْمَعُ ما له وما عليه، ويقترحُ بديلاً متوازناً تَشْهَدُ له النصوصُ والدراساتُ معاً.

ومنهجي في كل ذلك أن أُسندَ كلَّ دعوى علميةٍ إلى مصدرها، وأُصنِّفَ قوَّةَ الدليلِ بحسبِ منهجِ الطِّبِّ المبني على البراهين؛ فلا تُساوَى الشهادةُ الفرديةُ بالتجربةِ المضبوطةِ، ولا التجربةُ الواحدةُ بالمراجعةِ المنهجيةِ لعشراتِ الدراساتِ. وما لم يَثْبُتْ، قلتُ فيه: لم يَثْبُتْ، ولم أَجاوِزْ ذلك إلى جزمٍ لا يَمْلِكُهُ إلا اللهُ. وأرجو أن يخرجَ القارئُ من هذه الصفحاتِ لا بقائمةٍ «مسموحٍ ومنوعٍ» جديدةٍ يَسْتبدِّلُها بأخرى، بل بملَكَةٍ في الوزنِ والتمييزِ، هي خيرُ ما يَهْدِي إلى عقلٍ مسلمٍ في زمنٍ كَثُرَ فيه الناحسونَ وقلَّ فيه البرهانُ. واللهُ أَسْأَلُ التوفيقَ والسدادَ.

الفصل الأول

ما هو «نظام الطيّبات»؟ النشأة والفكرة والقواعد

قبل أن تَزَنَ شيئاً، يجب أن نَعْرِفَهُ على وجهه؛ فإنصافُ الخصم قبل نقده أمانةٌ علميةٌ وخلقٌ إسلاميٌّ. ولذلك أعرضُ في هذا الفصل النظامَ كما قدّمه صاحبه، معتمداً على ما نُشِرَ ونُقِلَ عنه، قبل أن أتقلَّ في الفصول التالية إلى الميزان.

أولاً: النشأة والسياق

يُنسَبُ «نظام الطيّبات» إلى الطبيب المصريّ ضياء الدين العوضي، وقد اشتهر نظامه وانتشر عبر مقاطع الفيديو والمنشورات على منصّات التواصل انتشاراً واسعاً، حتى صار حديثَ المجالس في غير بلدٍ عربيّ. وقد ربطَ صاحبه بين الغذاء «الحلال الطيب» وبين الصحة الجسدية ونمط الحياة، وقدّم نظامه بوصفه «أسلوب حياة» لا مجردَ حميةٍ مؤقتة. وفي التاسع عشر من أبريل عام 2026م تُوِّفِيَ صاحبُ النظام — رحمه الله ووسعه برحمته — عن نحو سبعةٍ وأربعين عاماً، بعد أسابيعٍ من قرارٍ صادرٍ عن النقابة العامة لأطباء مصر بشطب عضويته ومنعه من مزاولة المهنة، وأصدرت النقابة بياناً أكّدت فيه أن النظام «لا يستند إلى أدلةٍ علميةٍ أو تجاربٍ سريريةٍ معتمدة».

وأُسجِلُ هنا أمرين: الأولُ أنّ موتَ الإنسان ومرضه لا يصحُّ أن يُتَّخَذَا وحدهما دليلاً على بطلان فكرته؛ فالأنبياءُ والصالحون مَرَضُوا وماتوا، والمرضى قدَرُ يُصِيبُ البرَّ والفاجر.

والثاني أنَّ صحَّةَ الدعوى العلمية لا تُؤخَذُ من سيرة صاحبها مدحاً ولا قدحاً، بل من الدليل المجرد. فلننَّجْ جانباً قصةَ الرحيل وما دار حولها من جدلٍ، ولنزِنِ الفكرةَ بذاتها.

ثانياً: الفكرةُ الجوهريةُ

يقومُ النظامُ في جوهره على تقسيمٍ ثنائيٍّ حادٍّ للأطعمة إلى فئتين:

• **أطعمةٌ «طَيِّبةٌ»:** يَصِفُها بأنها «مُسْتَشْفِية» (أي شافية)، لأنها — بحسبِ طَرَحِهِ — سهلةٌ الهضم، قريبةٌ في قوامها من الحالةِ السائلة، تُشَبِّعُ أكثرَ وتتركُ «فضلاتٍ» أقلَّ في الجهازِ الهضمي.

• **أطعمةٌ «خبيثةٌ سامةٌ»:** يزعمُ أنها تُسبِّبُ الالتهاباتِ و«تُرهِقُ» الجهازَ الهضميَّ، فيجبُ استبعادُها بالكلية.

وهذا التقسيمُ الثنائيُّ هو حجرُ الزاويةِ في النظامِ كله؛ ومنه تنفَرِّعُ القوائمُ الطويلةُ من «المسموح» و«الممنوع». ولا حِظَّ القارئُ منذ الآن أنَّ مدارَ النظامِ على لفظي «طَيِّب» و«خبيث»، وهما لفظان قرآنيان لهما في كتابِ الله معنىٌ محدَّدٌ سنحرِّره في الفصلِ الثاني، وسنرى هل وافقَ النظامُ هذا المعنى أم خالفه.

ثالثاً: القواعدُ السلوكيةُ

إلى جانبِ قائمتيِ الطعامِ، وضعَ النظامُ قواعدَ في طريقةِ الأكلِ والشربِ، أبرزها:

(1) تفضيلُ الطعامِ والخضراواتِ المطبوخةِ على النيئةِ والورقية. (2) الأكلُ عندَ الشعورِ بـ«جوعٍ حقيقيٍّ» حتى الشبعِ، دونَ تقييدٍ بسعراتٍ حراريةٍ أو مواعيدَ ثابتة. (3) شربُ

الماء عند الشعور بالعطش فقط. 4) اعتماد فتراتٍ من الصيام المتقطع لإتاحة «وقتٍ للصيانة والتجديد الداخلي» للجسم.

رابعاً: ماذا يُبيح النظام وماذا يَمنع؟

قائمةُ «المسموح» واسعةٌ ومفاجئة؛ فهي تُبيح النشوياتِ نخبز القمح الكامل والأرز والبطاطس، والدهونِ بسخاءٍ كالزبد والسمن والقشدة وزيت الذرة وعباد الشمس، والأجبانَ الناضجة كالشيدر والبارميزان، واللحومَ الحمراء، والحلوياتِ كالبسبوسة والشوكولاتة والنوتيلا والمربى والسكر، والمكسراتِ (إلا قليلاً منها). أما قائمةُ «الممنوع» فتَحذفُ مجموعاتٍ غذائيةً كاملةً: الحليبَ ومنتجاتِ الألبانِ (كالزبادي والجبن القريش)، والبيضَ بجميع طرق طهيه، والدواجنَ (الدجاج والديك الرومي والبط)، والبقولياتِ (القول والعَدَس والحمص والفاصوليا)، ومعظمَ الخضراواتِ (الخيار والخس والجرجير والجزر والطماطم والسبانخ والملوخية)، وبعضَ الفواكهِ (كالبطيخ والبرتقال والكتنلوب).

ملاحظةٌ منهجيةٌ — يلفتُ النظرُ أنَّ النظامَ يُبيحُ السكرَ والشوكولاتةَ والبسبوسةَ والدهونَ المشبعةَ بسخاءٍ، بينما يَمنعُ البيضَ والعَدَسَ والزباديَ والبروكلي والسبانخ. وهذا الترتيبُ — كما سنرى — معكوسٌ في كثيرٍ من مفرداته عمّا تُجمعُ عليه إرشاداتُ التغذيةِ المعاصرة، وعمّا يقتضيه المعنى القرآني للطَّيبِ.

خامساً: مصدرُ سلطةِ النظام

من المهمّ أن ندركَ على أيِّ أساسٍ بُنيَ النظامُ؛ فهو لم يُعرَضْ ابتداءً كفرضيةٍ بحثيةٍ تُختَبَرُ في تجاربٍ سريريةٍ محكمةٍ، ولم يُنشرَ في دوريةٍ علميةٍ خاضعةٍ للمراجعة، وإنما قام أساساً على التجربة الشخصية والاستنتاج النظري وشهادات المتابعين. وهذه نقطةٌ جوهريةٌ سنعودُ إليها في الفصل الثالث؛ لأنَّ مصدرَ المعرفة هو أوَّلُ ما يُسألُ عنه حين نزنُ دعوى صحية: من أين عَرَفنا أنَّ هذا صحيح؟ والجوابُ عن هذا السؤال يُحدِّدُ سلفاً مقدارَ الثقة التي نمنحُها للدعوى قبل أن ننظرَ في تفاصيلها.

الفصل الثاني

المفهوم القرآني للطيبات - الطيب والخبيث في ميزان الوحي

ما دام النظام قد استعار اسمه من القرآن، فالعدل أن نرجع إلى القرآن نفسه لنسأله: ما الطيب الذي تعنيه؟ وهل المنع والتحريم من طبيعة هذه الكلمة أم نقيضها؟ وهذا الفصل تحرير لغوي وتفسيري للمصطلح من كتب أهل العلم المعتمدة.

أولاً: معنى «الطيب» في اللسان والشرع

قال الراغب الأصفهاني في «المفردات»: «أصل الطيب: ما تستلذه الحواس وما تستلذه النفس». ثم بين أن الطعام الطيب في الشرع: «ما كان متناولاً من حيث ما يجوز، ومن المكان الذي يجوز». فالطيب إذن يجمع وصفين: أن يكون حلالاً في كسبه وأصله (لا حرام ولا مغصوب)، وأن يكون مستلذاً غير مُستقذر في ذاته (لا ميتة ولا دمًا مسفوحاً ولا خنزيراً). فالطيب ضد الخبث والتجاسة، لا ضد ما لا يستسيغه ذوق فرد أو نظرية هضم خاصة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

قال الطبريُّ في تأويلها: «كُلُوا من حلالِ الرزق الذي أحلَّنا لكم فطاب لكم بتجليي إِيَّاه، مما كنتم تُحَرِّمون أنتم ولم أكن حرَّمته عليكم، من المطاعم والمشارب». فالآيةُ — كما ترى — أمرٌ بالأكل من الحلال، وإنكارٌ على من يُحرِّم على نفسه ما لم يُحرِّمه الله. وهذا المعنى نفسه يتكرَّر في غير موضع.

ثانياً: الأمرُ بالطَّيِّبات ردُّ على المانعين والمُسْرِفين معاً

ومن أدقِّ ما قاله المفسِّرون في هذه الآية أنَّ «الأمرَ بالأكل من الطَّيِّبات فيه ردُّ على الغلاة الذين يمتنعون عنها، وفيه ردُّ على الجفأة الذين لا يقتصرون عليها». فالميزانُ القرآنيُّ يرفضُ طرفين: طرفَ التحريم والمنع بلا حجة من الله، وطرفَ الإسرافِ والطغيانِ في الأكل. وهذا هو الاعتدالُ بعينه. وقد جاء النهيُّ عن الطغيان صريحاً مقروناً بالأمر بالطَّيِّبات:

﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي﴾

سورة طه: 81

قال ابن كثير: «كُلُوا مِنْ هَذَا الرِّزْقِ الَّذِي رَزَقْتُكُمْ، وَلَا تَطْغَوْا فِي رِزْقِي». فاللهي عن الطغيان — وهو مجاوزة الحد — هو ضابط النظام الغذائي في القرآن: لا منع لما أحلَّ الله، ولا إسراف فيما أحلَّه. وهذا يلتقي — كما سيظهر — مع جوهر ما توصي به هيئات التغذية المعاصرة من «الاعتدال» و«النمط المتوازن».

ثالثاً: تحريم الطيبات اعتداءً نهى عنه القرآن

بل إنَّ القرآن جعل تحريم الطيبات بغير إذنٍ من الله نوعاً من الاعتداء، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾

سورة المائدة: 87

فقرن تحريم الطيبات بالاعتداء، وهذا أصلٌ عظيم: أنَّ الأصلَ في الأطعمة الحلُّ، وأنَّ منع ما أباحه الله يحتاجُ إلى دليلٍ شرعيٍّ أو ضررٍ مُحَقَّقٍ ثابت، لا إلى نظرية هضمية أو ذوقٍ شخصيٍّ أو تقسيمٍ مُبتدع. وقد وَجَّهَ اللهُ من حرَّموا على أنفسهم ما أحلَّ لهم في غير ما آية، ومنها قوله: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: 32].

رابعاً: حصاُءُ الميزان القرآني

إذا جمعنا ما تقدّم خرجنا بأنّ المفهومَ القرآنيَّ للطّيِّباتِ يقومُ على أربعة أركان: (1) أنّ الطيّبَ هو الحلالُ المستلذُّ غيرُ المستقدّر، فالمناطُ شرعيٌّ لا ذوقيٌّ ولا نظريُّ. (2) أنّ الأصلَ في الأطعمة الإباحةُ والسَّعةُ لا المنعُ والتضييق. (3) أنّ تحريمَ الطّيِّباتِ بلا إذنٍ من الله اعتداءٌ منهٍ عنه. (4) أنّ الضابطَ هو الاعتدالُ: لا غلوٌّ في المنع، ولا طغيانٌ في الأكل.

المفارقة — حين نعرضُ «نظامَ الطّيِّباتِ» على هذه الأركان الأربعة، نجدُها يُخالفُها في أخطرها: فهو يبيِّنُ سلطانه على المنع والتَّحريم، ويحرِّمُ مجموعاتَ غذائيةٍ سمّاها الله طيّباتٍ صراحةً — كالعدس والفاصوليا والبيض واللبن — ويَجعلُ المناطَ نظريةً هضميةً خاصةً لا حكماً شرعياً ولا ضرراً ثابتاً. فالنظامُ استعار الاسمَ القرآنيَّ، لكنه سار في الاتجاه المعاكس لمضمونه. وهذه أوَّلُ علامةٍ على الخلل، قبل أن نفتح كتبَ الطيّبِ أصلاً.

الفصل الثالث

كيف نزن نظاماً غذائياً؟ مبادئ الطب المبني على البراهين

لكي يكون نقدنا منهجياً لا انطباعياً، نحتاج أولاً إلى أداة وزنٍ مُتَّفَقٍ عليها بين أهل الاختصاص. وأدأتنا هي «الطب المبني على البراهين» (Evidence-Based Medicine)، وهو منهجٌ يَرتَّبُ الأدلةَ بحسب قوتها، ولا يُسَوِّي بين الشهادةِ العابرةِ والتجربةِ المحكَّمةِ.

أولاً: هرمُ الأدلة — ليست كلُّ «الأدلة» سواء

في قاع الهرم تقع آراءُ الخبراء والشهاداتُ الفردية («جربته فشفيت»)، وهي أضعف الأدلة؛ لأنها عرضةٌ لأثرِ الإيحاء (placebo)، وللاتقاء (من لم ينجح لا يحدث)، ولا اجتماع أسبابٍ أخرى لم تُضبط. وفوقها دراساتُ الحالات والشواهد، ثم الدراساتُ الأترابية (الجماعية) المستقبلية التي تتبع آلاف الناس سنواتٍ وترصدُ علاقةَ غذائهم بأمراضهم. وأعلى من ذلك التجاربُ السريريةُ المعشاةُ المضبوطة التي تُوزعُ المشاركين عشوائياً. وعلى القمة تقع المراجعاتُ المنهجيةُ والتحليلاتُ البعدية (Meta-analysis) التي تجمع عشرات الدراسات في حصيلةٍ واحدة. فحين تتعارض شهادةٌ فرديةٌ مع تحليلٍ بعديٍّ لملايين المشاركين، فالعبرةُ بالأقوى.

قاعدةٌ ذهبيةٌ — «الدعوى الاستثنائيةُ تحتاجُ إلى أدلةٍ استثنائيةٍ». فدعوى علاج الأمراض المزمنة الخطيرة بنظامٍ غذائيٍّ لا تُثبتُ مقاطع الفيديو ولا التجارب الشخصية ولا الشهادات العاطفية، بل تحتاجُ إلى تجارب سريرية مضبوطة مُحكَّمة منشورة. وغياب هذا النوع من الدليل عن «نظام الطِّيبات» ليس تفصيلاً هامشياً، بل هو لبُّ المشكلة.

ثانياً: مسطرةٌ من ستِّ أسئلةٍ لوزنِ أيِّ حمية

يُمْكِنُ تلخيصُ ما يُجمَعُ عليه كثيرٌ من خبراء التغذية في ستِّ أسئلةٍ نطرحُها على أيِّ نظامٍ غذائيٍّ قبل اتِّباعه:

(1) **المنع أم الاعتدال؟** يُشير الدكتور روبرت شمرلينغ من كلية الطب بجامعة هارفارد إلى أنَّ العلماء لا يميلون إلى «ثقافة المنع الشامل» بل إلى الاعتدال، وأنَّ «كلَّ ما هو مفيدٌ لصحتك يكون أفضلَ باعتدال، وحتى أكثرُ العادات صحَّةً قد تضرُّ إذا أُفرط فيها». فالحميات القائمةُ على قوائمٍ طويلةٍ من المحرَّمات الصارمة تكون عادةً موضع شكٍّ علمي.

(2) **هل يَحذفُ مجموعاتٍ غذائيةٍ كاملة؟** حذفُ مجموعةٍ بأكملها (كالبقوليات أو الألبان) يفتحُ بابَ نقصِ العناصر ما لم يُعوَّضَ بعنايةٍ مدروسة.

(3) **ما موقفه من الدهون المشبعة والسعرات؟** الإباحة المطلقة للدهون دون نظرٍ في نوعها وكمِّها تصطدمُ بتوصيات هيئات القلب.

(4) هل يَحْفَظُ الأليافُ وميكروبيومَ الأمعاء؟ الأطعمةُ الغنيةُ بالألياف (البقوليات، الحبوب الكاملة، الخضراوات) تُغْذِّي بكتيريا الأمعاء النافعة المرتبطةً بصحة القلب والأيض.

(5) هل تعليماته عن الماء آمنة؟ الاكتفاء بإشارة العطش قد يكون متأخراً، خاصةً لكبار السنِّ وأصحاب الأمراض المزمنة.

(6) هل يُعَمِّمُ أنماطاً قد تَضُرُّ بعضَ الناس؟ كالصيام المتقطِّع الذي قد لا يُناسبُ كلَّ الحالات.

ثالثاً: لماذا هذه المسطرةُ عادلة؟

لأنها لا تُصمِّمُ على رفض «نظام الطيبات» وحده، بل تَصْلُحُ لِوَزْنِ أيِّ نظامٍ مهما كان مصدره — كيتو أو نباتي أو غيره. فهي ليست خصومةً، بل آلةٌ قياسٍ. وستظهرُ في الفصول القادمة نتيجةٌ مزدوجة: أنَّ النظامَ يَسْقُطُ في أكثر بنود هذه المسطرة (المنع الشامل، حذف المجموعات، إطلاق الدهون، خسارة الألياف)، لكنه يُصِيبُ — جزئياً — في بند واحدٍ مهمٍّ هو التحذيرُ من الأطعمة فائقة المعالجة والسكر، وإن كان نظامه نفسه يُبيحُ كثيراً منها! وهذا التناقضُ الداخليُّ من أعجبِ ما في النظام، وسنُفَصِّلُه في موضعه.

قبل أن نَمْضِي — سنُصنِّفُ في كلِّ فصلٍ قادمٍ قوَّةَ الدليلِ إلى: «قوي» (تحليلٌ بعديٌّ أو تجاربٌ معشاةٌ متَّسقة)، و«متوسط» (دراساتٌ أترابيةٌ متعددة)،

و«محدود» (دراساتٌ قليلةٌ أو متعارضة). وبهذا يَمْتَلِكُ القارئُ — لا الكاتبُ وحده — أدواتَ الحكم.

الفصل الرابع

البقوليّات والحبوب الكاملة – حذفُ ركائزِ أثبت العلمُ نفعَها

من أوضح مواطن الخلل في «نظام الطيّبات» منعه البقوليّات بأنواعها: القول والعَدَسَ والحمصَ والفاصوليا واللوبيا. وهذه – في موروثنا الغذائيّ وفي علم التغذية معاً – من أنفع ما يأكله الإنسان: مصادرٌ غنيّةٌ بالبروتين النباتيّ والألياف والمعادن، رخيصةٌ متاحةٌ مُشجّعة. فما الذي يقوله العلمُ في حذفها؟

أولاً: البقوليّات والوفيات

أُجريت تحليلاتٌ بعديّةٌ (Meta-analyses) لدراساتٍ أترابيةٍ مستقبليةٍ تَبَعَت مِثَالِ الآلاف من الناس، فربطت بين تناول البقوليّات وانخفاض الوفيات.

الدليل: تحليلٌ بعديٌّ نُشِرَ عام 2017م جمع ستّ دراساتٍ أترابيةٍ مستقبليةٍ شملت نحو 219 ألف مشارك، فوجد أنّ أعلى فئات تناول البقوليّات ارتبطت بانخفاض الوفيات من كل سبب بنسبةٍ بلغت خطرها النسبي 0.93 (أي انخفاض نحو 7%). وأما الوفيات القلبية الوعائية فكان الأثر في اتجاه الحماية لكنه لم يبلغ حدّ الدلالة الإحصائية في التحليل العام **قوة الدليل: متوسط**

دليلٌ مساعد: تحليلٌ بعديٌّ آخرٌ لخمس دراساتٍ مستقبليةٍ شملت آلاف حالاتٍ نقص تروية القلب وجد انخفاضاً في خطر داء القلب الإقفاري بنحو 14% (خطر نسبي 0.86) عند أعلى تناولٍ للبقوليات مقارنةً بأدناه **قوة الدليل: متوسط**

والإنصافُ العلميُّ يقتضي أن نقول: إنَّ الأثرَ الوقائيَّ للبقوليات على الوفياتِ القلبية تحديدًا متفاوتٌ بين الدراسات، وبعضها لم يجد دلالةً قويةً في التحليل العام، وإنَّ ظهرت الحماية في تحليل «الجرعة-الاستجابة». لكنَّ ما يهْمُنَا هنا أمرٌ حاسم: لا توجدُ ولا دراسةٌ واحدةٌ معتبرةٌ تربطُ تناولَ البقوليات بضررٍ يُبرِّرُ حذفها من الغذاء. فأسوأُ ما يُقالُ في البقوليات أنها «محايدة» على القلب، وأحسنُ ما يُقالُ أنها «واقية». وفي الحالين، فحذفها خسارةٌ لا مكسب.

ثانيًا: الحبوب الكاملة — الدليلُ هنا أقوى

أما الحبوبُ الكاملةُ فالدليلُ على نفعها أقوى وأوضح. ففي تحليلٍ بعديٍّ لـ«الجرعة-الاستجابة» لدراساتٍ أترابيةٍ متعددة، ارتبطت كلُّ زيادةٍ مقدارها عشرة غراماتٍ يوميًا من الحبوب الكاملة بانخفاض خطر الوفاة القلبية الوعائية بنحو 4%. وفي المقابل، ارتبطت كلُّ زيادةٍ مقدارها عشرة غراماتٍ من اللحوم الحمراء والمصنَّعة بزيادة خطر الوفاة القلبية بنحو 1.8%.

الدليل: تحليلٌ بعديٌّ لاستهلاك عشر مجموعات غذائيةٍ والوفياتِ القلبية خلص إلى أنَّ ارتفاعَ تناولِ الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه والمكسرات، وانخفاضَ تناولِ اللحوم الحمراء والمصنَّعة، يرتبطُ بانخفاضِ الوفياتِ القلبية الوعائية **قوة الدليل: قوي**

والمفارقةُ المؤلمةُ أنَّ النظامَ يُبيحُ اللحومَ الحمراءً بسخاءٍ — وهي التي ارتبطت بزيادةِ الخطر — ويمنعُ البقولياتِ والحبوبَ الكاملةَ — وهي التي ارتبطت بالحماية أو الحياد. فهو يستبدلُ الذي هو أدنى بالذي هو خير.

ثالثاً: الأليافُ وميكروبيومُ الأمعاء

للبقوليات والحبوب الكاملة فضلٌ خاصٌ يتجاوزُ القلبَ إلى الأمعاء: فهي غنيةٌ بالألياف التي تُغذي البكتيريا النافعةَ في الأمعاء (الميكروبيوم)، وهذه بدورها مرتبطةٌ بصحة الأمعاء، وتنظيمِ السكر، والشبع، وتقليلِ خطرِ أمراض القلب والسكري وبعض السرطانات، بل ببعض مؤشرات طول العمر. وحذفُ البقوليات والحبوب — كما في «الطبيبات» — يعني خسارةَ ركيزةٍ مهمةٍ من ركائزِ صحة الأمعاء، ما لم تُعوَّضَ بمصادرٍ أخرى مدروسة، وهو ما لا يُيسره النظامُ إذ يمنعُ معها معظمَ الخضراوات أيضاً.

وتأمل كيف يلتقي العلمُ هنا مع الوحي: فقد سمى اللهُ هذه الأطعمةَ من الطبيبات، وعدَّ منعها اعتداءً، والعلمُ يقولُ إنَّ منعها خسارةٌ صحيّة. فالميزانان متفقان.

✓ مما له: لا شيء — لم يرد في النظام مبررٌ علميٌّ صحيحٌ لمنع البقوليات أو الحبوب الكاملة

✗ مما عليه: حذفُ مجموعةٍ غذائيةٍ ثبتَ نفعُها أو حياؤها على القلب

✗ مما عليه: خسارةُ مصدرٍ رئيسٍ للبروتينِ النباتيِّ والأليافِ الرخيصةِ المتاحة

✗ مما عليه: إفقارُ ميكروبيومِ الأمعاء، وما يتبعُه من آثارٍ أضرارٍ ومناحية

✗ مما عليه: مخالفةُ صريحِ القرآنِ الذي سمّاها طيّباتٍ ونهى عن تحريمها

الفصل الخامس

البيض والألبان والدواجن – مجموعات محذوفة بلا دليل

يَمْنَعُ النظامُ البيضَ بجميع طرق طهيهِ، والحليبَ ومنتجات الألبان (الزبادي والجبن القريش)، والدواجن (الدجاج والديك الرومي والبط). وهذه ثلاث مجموعات بروتينية مهمة شائعة في موائد الناس. فلننظر في كلٍّ منها.

أولاً: البيض

طُورِدَ البيضُ عقوداً بتهمة الكوليسترول، ثم جاءت الأدلة الحديثة لتُعيد النظر. فالبيض مصدرٌ ممتاز للبروتين عالي القيمة، والكولين، والفيتامينات. وأكثر الدراسات الأتريبية الكبيرة لم تجد لتناول معتدل للبيض (نحو بيضة يومياً) أثراً يُذكر على خطر القلب لدى عموم الناس، مع تفاوتٍ في حالات السكري يستدعي بعض التحفظ. والخلاصة أنَّ البيض – لعموم الأصحاء – طعامٌ مغذٍ يُؤكَلُ باعتدال، لا «خبثٌ سامٌ» يُحذف بالكلية.

الموقف العلمي: لا يوجد دليلٌ معتبر يُصنّف البيض في خانة الأطعمة التي يجب حذفها لعموم الناس؛ بل هو مصدرٌ بروتيني وكوليّن عالي الجودة. التحفظ الوحيد يخص الإفراط أو حالات مرضية بعينها

قوة الدليل: متوسط

ثانياً: الألبان

الألبان مصدر رئيس للكالسيوم والبروتين وفيتامين D (المدعم) والبروبيوتيك في حالة الزبادي المخمر. والأدلة على الألبان كاملة الدسم متفاوتةٌ بحسب نوع المنتج: فمنتجات الألبان المخمرة كالزبادي تَمِيلُ إلى الحياد أو النفع، في حين أنَّ الدهون المشبعة المرتفعة في بعض منتجات الألبان كاملة الدسم تستدعي الاعتدال. لكنَّ الحذف الكلي للألبان — وبخاصة الزبادي والقريش قليل الدسم — لا يُسِنِّده دليلٌ علمي، بل يُفَوِّتُ مصدراً مهماً للكالسيوم يصعبُ تعويضه، خاصةً مع منع النظام لمعظم الخضراوات الورقية أيضاً.

الدليل: في تحليل مجموعات غذائية متعددة، لم يرتبط تناول منتجات الألبان بزيادة دالة في الوفيات القلبية الوعائية في التحليل العام؛ والزبادي المخمر على وجه الخصوص يُظهر إشاراتٍ نافعةً على الأبيض وصحة الأمعاء **قوة الدليل: متوسط**

ثالثاً: الدواجن

أما منع الدواجن فهو من أغرب بنود النظام؛ إذ إنَّ الدجاج منزوع الجلد يُعدُّ في الإرشادات المعتمدة من البروتينات «الصحية للقلب»، وهو أقلُّ دهوناً مشبعةً من اللحوم الحمراء التي يُبيحها النظامُ بسخاء! فكيف يُمنعُ الأقلُّ ضرراً ويُباحُ الأكثر؟ هذا قلبٌ للأولويات لا يُسِنِّده علم.

الموقف العلمي: تُدرِّجُ جمعية القلب الأمريكية الدواجن منزوعة الجلد ضمن البروتينات الصحية للقلب، وتوصي بتفضيلها على اللحوم الحمراء والمصنَّعة **قوة الدليل: قوي**

ملاحظة جامعة – حين يَحذفُ نظامُ ثلاثِ مجموعاتِ بروتينيةٍ صحيّةٍ (الببيض، الألبان قليلة الدسم، الدواجن)، ويُبقي مكانها اللحوم الحمراء والأجبان الدهنية والحلويات، فإنه يدفعُ متبعه – من حيث لا يشعر – نحو نمطٍ أعلى في الدهون المشبعة وأقفر في تنوع البروتين. وهذا عكس ما يُوصي به العلم.

✓ مما له: لا مبرر علمياً صحيحاً لحذف هذه المجموعات الثلاث لعموم الأصحاء

✗ مما عليه: حذف البيض: خسارة بروتين وكولينٍ عالي الجودة بلا دليل ضرر

✗ مما عليه: حذف الألبان: خسارة مصدرٍ رئيسٍ للكالسيوم يصعبُ تعويضه

✗ مما عليه: حذف الدواجن: منع بروتينٍ «صحيٍّ للقلب» مع إباحة ما هو أعلى دهوناً مشبعة

✗ مما عليه: الدفعُ نحو نمطٍ أقفر تنوعاً وأعلى في الدهون المشبعة

الفصل السادس

الخضراوات والفواكه - حين يُمنَعُ أنْفَعُ الطعام

يَصِلُ التقسيمُ الثنائيُّ في النظام إلى ذروته حين يَمْنَعُ معظمَ الخضراوات - الخيارَ والخسَّ والجرجيرَ والجزرَ والطماطمَ والسبانخَ والملوخيةَ والكرنبَ - ويُقَيِّدُ الفواكهَ، بل يَمْنَعُ بعضها كلياً كالبطيخَ والبرتقالَ والكتنالوب. وهنا تَبْلُغُ المخالفةُ للعلم وللوجي معاً منتهاها؛ فالخضراوات والفواكه هي الطيبات في أبسطِ صورها، وهي جُرُ الزاوية في كل نمطٍ غذائيٍّ صحيٍّ على وجه الأرض.

أولاً: ما الذي تُجْمَعُ عليه الأدلة؟

من النادر في علم التغذية أن تَجِدَ مسألةً يَكَادُ يُجْمَعُ عليها الباحثون كإجماعهم على نفع الخضراوات والفواكه. فالتحليلاتُ البَعْدِيَّةُ الكبيرةُ تَرَبِّطُ بين ارتفاع تناولها وانخفاض خطر أمراض القلب والسكتة وبعض السرطانات والوفيات من كل سبب. وهي مصادرٌ للألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمرتبات النباتية الفعّالة، بسرعاتٍ منخفضةٍ وكثافةٍ غذائيةٍ عاليةٍ.

الدليل: تُجْمَعُ الإرشاداتُ الكبرى (كإرشادات جمعية القلب الأمريكية) على التوصية بتناول مجموعةٍ متنوعةٍ من الفواكه والخضراوات يومياً بوصفها ركيزةً للنمط

الغذائي الصحي للقلب؛ وترتبط التحليلات البعدية ارتفاع تناولها بانخفاض الوفيات

قوة الدليل: قوي

ثانياً: حجة «النبي يرهق الهضم» في الميزان

يُعَلِّلُ النظامُ منعَ الخضراوات الورقية والنبتة بأنها «تُرهقُ» الجهازَ الهضميَّ وتتركُ «فضلات». وهذا تعليلٌ يخلطُ بين أمرين: فما يُسمَّى «فضلات» هو في الحقيقة الأليافُ الغذائية، وهي ليست عبئاً يُخلَّصُ منه، بل غذاءٌ لبكتيريا الأمعاء النافعة، وعاملٌ أساسيٌّ في انتظام الهضم والشع وضبط السكر والكوليسترول. فما اعتبره النظامُ عيباً هو في الحقيقة من أعظم منافع هذا الطعام. نعم، قد تستدعي بعضُ الحالات المرضية الخاصة (كمتلازمة القولون العصبي في نوباتها) تعديلاً مؤقتاً في الألياف بإشراف طبيب، لكنَّ تعميمَ المنع على عموم الأصحاء قلبٌ للحقيقة.

ثالثاً: تقييدُ الفواكه

أما قاعدة «صنف واحد فقط على فترات متباعدة» ومنعُ فواكه بعينها، فلا يُسندها دليلٌ معتبر. صحيحٌ أنَّ الإفراط في العصائر المحلاة أو تركيز السكريات السريعة أمرٌ يُتَحَفَّظُ منه (وهذا ينطبق على العصائر المصفّاة لا الفاكهة الكاملة)، لكنَّ الفاكهة الكاملة بأليافها من أنفع ما يؤكَل، ومنعُ البرتقال والبطيخ — وهما من خير الطيبات ماءً وفيتامينات — لا معنى له عليها.

المفارقة الكبرى — يُمنع النظامُ البسبوسةَ والشوكولاتةَ والنوتيلا والسكرَ، ويمنعُ السبانخَ والبروكلي والبرتقالَ والبطيخَ. فأَيُّ ميزانِ هذا الذي يُحرِّمُ الطَّيِّبَ ويُحِلُّ ما هو أدنى منه نفعاً؟ إنه — بمنطق القرآن — تحريمٌ للطَّيِّباتِ واعتداءٌ، وبمنطق العلم — قلبٌ للهرمِ الغذائيِّ رأساً على عقب.

✓ مما له: لا شيء — منعُ الخضراوات والفواكه يخالف أقوى ما في علم التغذية من إجماع

✗ مما عليه: حذفُ أعلى الأطعمة كثافةً غذائيةً وأقلَّها سرعات

✗ مما عليه: خسارةُ الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة

✗ مما عليه: تعليلٌ خاطئٌ يعدُّ الأليافَ النافعةَ «فضلاتٍ مرهقة»

✗ مما عليه: إباحةُ الحلويات والسكر في مقابل منع الخضراوات — قلبُ تأمُّ للأولويات

الفصل السابع

الدهون والسعرات — الإباحة المطلقة في مواجهة توصيات القلب

من سمات النظام أنه يُبيحُ الدهونَ بسخاء — الزبدَ والسمنَ والقشدةَ والأجبانَ الدهنيةَ والخبزَ المحمَّرَ — ويُلغِي حسابَ السعرات، داعياً إلى الأكل «حتى الشبع» دون تقييد. وهذه نقطةٌ تصطدمُ مباشرةً بتوصيات أكبر هيئات القلب في العالم.

أولاً: الدهون المشبعة في ميزان جمعية القلب

أثبتت الدراساتُ أنَّ الدهونَ المشبعةَ — الموجودةَ في الزبدة والقشدة والأجبان الدهنية وبعض المخبوزات والمقليات — قد ترفعُ مستويات الكوليسترول وتزيدُ خطرَ أمراض القلب والسكتة الدماغية. ولذلك تُوصي جمعية القلب الأمريكية — التي لا تُصدرُ توصياتها إلا بعد مراجعةٍ واسعةٍ للأدلة — بالآلا تتجاوزَ نسبةَ السعرات من الدهون المشبعة 6% من إجمالي السعرات اليومية.

الدليل: تُوصي جمعية القلب الأمريكية بالآلا تتجاوزَ الدهون المشبعة نحو 6% من السعرات اليومية؛ أي ما يقاربُ 13 غراماً يومياً لمن يتناولُ نحو 2000 سعرة. والإباحة المطلقة للدهون دون مراعاة النوع والكم تتضادُ مع هذه التوصية

قوة الدليل: قوي

ثانياً: إلغاء حساب السعرات

صحيح أن هوس عدّ السعرات ليس ضرورياً لكل أحد، وأن نوعية الطعام مهمة كميتها؛ لكن إلغاء الوعي بالطاقة كلياً مع إباحة الدهون والحلويات بسخاء وصفة محتملة لفائض السعرات وزيادة الوزن لدى كثير من الناس. والموازنة بين الطاقة المتناولة وحاجة الجسم تبقى من المبادئ الأساسية للحفاظ على وزن صحي، كما تُقرر الإرشادات.

ثالثاً: الصورة الكاملة أهم من حكم مفرد

تنبه جمعية القلب إلى أن العبرة بالنمط الغذائي كاملاً لا بحكم مفرد على طعام بعينه. والنمط الذي توصي به يقوم على: الحبوب الكاملة، والبروتينات النباتية، وتنوع الفواكه والخضراوات، وتقليل الملح والسكر والدهون الحيوانية والأطعمة المصنعة، مع إدخال البقوليات والمكسرات والأسماك واللحوم قليلة الدسم والدواجن منزوعة الجلد. وحين نقابل هذا النمط بنمط «الطيبات» نجد تعارضاً في معظم المفردات: فالنظام يحذف البقوليات والدواجن ومعظم الخضراوات، ويطلق الدهون المشبعة والحلويات.

✓ مما له: التنبه إلى نوعية الطعام لا كمّه فقط فكرة سليمة في أصلها

✗ مما عليه: إباحة الدهون المشبعة بسخاء يتضاد مع توصية «أقل من 6% من السعرات»

✗ مما عليه: إلغاء الوعي بالطاقة مع إطلاق الحلويات قد يفضي إلى فائض سعرات

✕ مما عليه: بنية النمط العامة معاكسة لما تُوصي به هيئات القلب

الفصل الثامن

الماء والعطش والصيام المتقطع - قواعدٌ تحتاج إلى تحفظ

يَضَعُ النظامُ قاعدَتَيْنِ سلوكيتين تستحقّان وقفةً: «اشرب عند العطش فقط»، و«اعتمد الصيام المتقطع». وكلاهما ليست خاطئةً على إطلاقها، لكنهما تحتاجان إلى تحفُّظٍ وتفصيلٍ يَغيبُ عن الطرح العام للنظام.

أولاً: الماء وإشارة العطش

يرى خبراءُ الترطيب أنَّ الاعتمادَ على إشارة العطش وحدها قد يكون متأخراً؛ فالعطش أشبهُ بجرس إنذارٍ يَنْبَغُ إلى بداية جفافٍ خفيفٍ قد لا يظهرُ إلا بعد فقدانٍ يتجاوزُ لترًا ونصفًا من الماء عبر التنفس والتبول والتعرق. وتبقى قاعدةُ «نحو ثمانية أكواب يوميًّا» مرجعًا عمليًّا مبسّطًا لكثيرٍ من الناس، مع تعديلها بحسب النشاط والمناخ والحالة الصحية.

الموقف العلمي: الاكتفاء بإشارة العطش قد لا يكون آمنًا للجميع، خاصةً كبار السن (الذين تضعفُ لديهم حساسيةُ العطش) وأصحاب الأمراض المزمنة وفي الأجواء الحارة. والإفراط في الماء كذلك غير مطلوب؛ فالمطلوبُ ترطيبٌ متوازن لا انتظار العطش الشديد

قوة الدليل: متوسط

ثانياً: الصيام المتقطع

الصيام المتقطع ليس باطلاً في ذاته، وله في بعض الدراسات فوائد على الوزن وحساسية الإنسولين لدى بعض الناس، وهو قريبٌ في صورته من سُنّة الصيام في شرعنا. لكنّ تعميمه كنصيحة عامة للجميع يحتاجُ إلى حذر؛ فبعض أنماطه أثارت أبحاثٌ حديثة حولها علاماتٍ استفهام.

الدليل: مراجعةٌ منهجيةٌ نُشرت عام 2019م وجدت أنّ مَنْ يَحْتَطُونَ وجبة الإفطار بانتظام كانوا أكثرَ عرضةً لأمراض القلب والأوعية بنسبة 21%، وخطر الوفاة المبكرة بنسبة 32%. كما أشارت بياناتٌ أوليةٌ عُرِضَتْ في مؤتمرٍ لجمعية القلب الأمريكية عام 2024م إلى أنّ حصرَ الأكل في ثماني ساعات فقط يومياً قد يرتبطُ بزيادةٍ في خطر الوفاة بأمراض القلب — وهي بياناتٌ أوليةٌ تحتاجُ إلى تأكيد

قوة الدليل: محدود إلى متوسط

والقراءة المنصفة لهذه الأدلة أنها لا تنفي كلّ أشكال تقنين الأكل، لكنها تُذكرُ بأنّ الصيام المتقطع ليس «آمناً تلقائياً» للجميع، وأنّ تعميمه دون نظرٍ في حالة الفرد — حاملٍ أو مريضٍ سكرٍ أو مَنْ يتناول أدويةً معينة — قد يضرُّ. فالضابط هو التفصيل والاستشارة الطبية، لا الإطلاق.

خلاصة الفصل — هذه القواعد السلوكية هي أقربُ بنود النظام إلى الاعتدال، لكنها قدّمت بإطلاقٍ يفتقرُ إلى التفصيل الذي تقتضيه الأمانة العلمية. فالماء يُشربُ بانتظام لا انتظاراً للعطش الشديد، والصيام المتقطع خيارٌ فرديٌّ مشروطٌ لا وصفةٌ عامة.

الفصل التاسع

الأطعمةُ فائقةُ المعالجةِ والسكرُ — حيث يلتقي النظامُ مع العلم جزئياً

لم يكن الإنصافُ ليكتَمَل لو مَضَى الكتابُ كُلُّهُ في بيان ما على النظامِ دون أن يَقِفَ عند ما له. وفي هذا الفصل نَصَلُ إلى النقطة التي يَلْتَقِي فيها «نظامُ الطيِّبات» — في بعض مقاصده العامة — مع ما يقوله العلم الحديث: وهي التَنفِيرُ من الأطعمة الصناعية فائقة المعالجة. غير أنَّ هذا الالتقاء، كما سنرى، يَبْقَى ناقصاً، بل يَنْقُضُه النظامُ بيده حين يُبَيِّحُ من السكرِ والحلويات ما يُناقِضُ مقصده المعلن.

أولاً: ما الذي أصاب فيه النظامُ؟

حين يَدْعُو النظامُ إلى الابتعاد عن الأطعمة المصنَّعة الجاهزة والإقبال على الطعام المطبوخ في البيت، فهو يلتقي في هذا المقصد العام مع توجُّهٍ راسخٍ في علم التغذية. فالأطعمةُ فائقةُ المعالجة (Ultra-Processed Foods) صارت محلَّ قلقٍ علنيٍّ متزايدٍ، وهي الأطعمة الصناعية المحمَّلةُ بالسكريات والدهون المُهدرَجة والأُملاح والمُضافات، كالمشروبات الغازية والوجبات الجاهزة والوجبات السريعة.

الدليل: مراجعةٌ مظليَّةٌ كبرى نُشِرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) عام 2024م، جمعت أدلةً نحو عشرة ملايين مشارك، ربطت بين الإكثار من الأطعمة فائقة المعالجة

واثنين وثلاثين أثراً صحياً ضاراً، شملت أمراض القلب والأوعية، والسكري من النوع الثاني، والاكتئاب، والوفاة المبكرة **قوة الدليل: قوي**

فمن جهة الدعوة إلى الطعام الطازج المعد في البيت، والابتعاد عن الأطعمة الصناعية المعلّبة، يُحسب للنظام أنه سائر ما تدعو إليه هيئات الصحة. وهذه نقطة ينبغي الاعتراف بها دون تردد؛ فالحقُّ أحقُّ أن يتبع ولو جاء على لسان من نخالفه في أكثر طرحة.

ثانياً: المفارقة التي تنقُض المقصد

لكنَّ المفارقة الكبرى أنَّ النظام — وهو يُحذِّر من «الخبث» — يبيح في قائمة مسموحاته السكر الأبيض والشوكولاتة والنوتيلا والمربى والبسبوسة والعصائر المعلّبة. والسكر المضاف والحلويات هي في صميم ما تُحذِّر منه إرشادات التغذية، وهي من أبرز مكونات الأطعمة فائقة المعالجة التي يزعم النظام محاربتها. فكيف يُحارب المعالج ويبيح السكر المركز؟

الدليل: توصي جمعية القلب الأمريكية بتقليل السكر المضاف قليلاً حازماً؛ إذ يرتبط الإفراط فيه بالسمنة وارتفاع الدهون الثلاثية والسكري وأمراض القلب. وإباحة الحلويات والشوكولاتة والمربى يومياً تتعارض مع هذه التوصية تعارضاً مباشراً **قوة الدليل: قوي**

وهنا يظهر الخلل المنهجي في معيار النظام: فهو لم يُصنّف الطعام بحسب أثره الصحي الذي تُثبتته الدراسات، بل بحسب معيار ذاتي غامض («سهولة الهضم» و«ترك الفضلات»)، فأفضى به هذا المعيار إلى أن يُحرّم العدس والزيادي والبيض — وهي

من أنفع الطعام - وَيُبَيِّحُ السَّكَّرَ والشوكولاتة. فالمقصدُ الجزئيُّ الصائبُ (محاربةُ المصنَّع) أبطله المعيارُ المعوجُّ في التطبيق.

✓ مما له: الدعوةُ إلى الطعام الطازج المعدّ منزلياً والنفورُ من الأطعمة المصنَّعة الجاهزة مقصدٌ يوافقُ العلم

✗ مما عليه: إباحةُ السَّكَّرِ والشوكولاتة والمرتبى والبسبوسة تنقُضُ هذا المقصدَ نفسه

✗ مما عليه: المعيارُ الذاتيُّ («سهولةُ الهضم») لا يُمَيِّزُ الضارَّ من النافع كما يُمَيِّزُهُ الدليلُ الصحي

الفصل العاشر

دعوى علاج الأمراض المزمنة – أين الدليل؟

أخطرُ ما في «نظام الطِّبِّيات» ليس قوائمه الغذائية، بل دعواه العريضة بأنه يُعالجُ أو يقي من أمراضٍ مزمنةٍ كالسكري وأمراض القلب وأمراض المناعة الذاتية. وهذه الدعوى – بحجمها – هي التي تستوجبُ أعلى درجات التدقيق؛ فإنَّ قاعدةً راسخةً في العلم تقول: «الدعاوى الاستثنائيةُ تحتاجُ إلى أدلةٍ استثنائيةٍ».

أولاً: ميزانُ الدعوى الكبرى

حين يزعمُ نظامٌ غذائيُّ أنه يشفي أمراضاً عجزَ عنها الطبُّ، فإنَّ عبءَ الإثبات يقعُ عليه هو، لا على من يُشكِّكُ فيه. والإثباتُ المقبولُ في مثل هذه الدعوى ليس شهاداتٍ متابعين قالوا «تحسَّنتُ حالتي»، فهذه – على كثرتها – لا ترقى إلى دليل، لأسبابٍ يعرفها أهلُ المنهج: منها التحسُّنُ التلقائيُّ لبعض الأمراض، وأثرُ الإيحاء (البلاسيبو)، وتغيُّرُ عاداتٍ أخرى مع النظام (كترك التدخين أو إنقاص الوزن أو الإقلال من المصنَّع)، وانحيازُ النشر (إذ يروى نجاحُ من تحسَّنَ وينسى من لم يتحسَّنَ أو تضرَّرَ).

الموقف العلمي: لا يُوجدُ – حتى تاريخ تأليف هذا الكتاب – تجاربٌ سريريةٌ محكمةٌ منشورةٌ في دورياتٍ علميةٍ مُراجعةٍ تُثبتُ أنَّ هذا النظام بعينه يُعالجُ مرضاً مزمنًا.

والدعوى الطبية بلا تجربة مضبوطة تبقى فرضيةً غير مثبتة، مهما كثرت الشهادات الفردية **قوة الدليل: الدعوى غير مدعومة بدليل**

ثانياً: موقف الجهة المهنية

سبق أن أشرنا إلى أنَّ النقابة العامة لأطباء مصر أصدرت بياناً أكدت فيه أنَّ النظام لا يستند إلى أدلة علمية أو تجارب سريرية معتمدة. وأياً كان الرأي في ملاسبات القرار، فإنَّ جوهر الملاحظة العلمية يبقى قائماً: غياب الدليل المنشور المحكَّم. وهذا الغياب وحده كافٍ لردِّ الدعوى الكبرى إلى دائرة «غير المثبت».

ثالثاً: خطر التطبيب الذاتي

وثمة خطر عمليٌّ يجب التنبيه عليه: أن يترك مريض السكري أو القلب علاجه الموصوف ثقةً بنظام غذائيٍّ يعده بالشفاء. فهذا قد يُفضي إلى مضاعفات خطيرة. والنصيحة الأمينة أنَّ الغذاء المتوازن جزءٌ من إدارة المرض المزمن لا بديلٌ عن العلاج الطبي، وأنَّ أيَّ تعديلٍ غذائيٍّ جوهريٍّ لمريضٍ مزمنٍ ينبغي أن يكون بإشراف طبيبه.

✓ مما له: التذكير بأهمية الغذاء في الوقاية من الأمراض المزمنة مقصدٌ صحيح في الجملة

✗ مما عليه: دعوى «علاج» الأمراض المزمنة بلا تجارب سريرية محكَّمة دعوى غير مثبتة

✗ مما عليه: الشهادات الفردية لا تقوم مقام الدليل لتعدد أسباب التحسُّن الظاهري

✕ مما عليه: خطرُ إحلال النظام محلَّ العلاج الطبي للمريض المزمن خطرٌ حقيقي

الفصل الحادي عشر

خلاصة الميزان — نحو نمط غذائي متوازن

بعد أن وَزَّنا النظامَ بدءاً بنداً، يَحْسُنُ أَنْ نَجْمَعَ خيوطَ الكتابِ في خلاصةٍ منصفةٍ، ثم نُقَدِّمَ بديلاً إيجابياً، فالتقدُّ وحده لا يكفي، والقارئُ الذي تركَّاه بلا بديلٍ كمن أطفأنا سراجَه ولم نُعطِه نوراً.

أولاً: ميزانُ النظامِ في جملةٍ واحدة

«نظامُ الطَّيِّباتِ» نظامٌ استعارَ اسماً قرآنياً جليلاً، وانطلق من حدسٍ شخصيٍّ لا من منهجٍ بحثيٍّ، فأصاب في مقاصدَ عامةٍ (النفورُ من المُصنَّع، الإقبالُ على الطعامِ الطازج، عدمُ الهوسِ بعدَّ السرعات)، وأخطأ في تطبيقاتٍ كثيرةٍ (تحرِيمُ مجموعاتٍ غذائيةٍ نافعةٍ بلا دليل، وإباحةُ السُّكَّرِ والدهونِ المشبعةِ بسخاء، والدعوى العريضةُ بالشفاء). فهو في ميزانِ الوحي قَلَبَ معنى «الطَّيِّباتِ» من الإباحةِ إلى المنعِ، وفي ميزانِ العلم خالَفَ في معظمِ مفرداته ما تُجْمَعُ عليه إرشاداتُ التغذيةِ.

ثانياً: المفهوم القرآني بوصفه ميزاناً

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ
لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾

المائدة: 87

عجيب أن يكون عنوان النظام «الطيبات»، ثم يكون جوهره تحريم كثير من الطيبات! والقرآن ينهى عن هذا التحريم صراحةً، ويجعله نوعاً من الاعتداء. فالمنهج القرآني في الطعام منهج سعة واعتدال: إباحة واسعة للطيبات، ونهي عن الإسراف، ونهي عن تحريم ما أحل الله. وهذا الميزان وحده كفيلاً بنقض بنية النظام القائمة على المنع.

ثالثاً: البديل المتوازن — ما يشهد له الوحي والعلم

إنَّ النمط الغذائي الذي تلتقي عليه إرشادات القلب والتغذية المعاصرة هو نفسه النمط الذي يوافق روح الاعتدال القرآني. وملاحظه:

- **أكثر من:** الحبوب الكاملة، والبقوليات (الفول والعدس والحمص)، وتنوع الخضراوات والفواكه، والبروتينات قليلة الدسم (الأسمك والدواجن منزوعة الجلد والبيض)، ومنتجات الألبان المعتدلة، والمكسرات والزيتون الصحية كزيت الزيتون.

• **أقل من:** السكر المضاف والحلويات، والدهون المشبعة (أقل من 6% من السعرات)، والملح، واللحوم المصنّعة، والأطعمة فائقة المعالجة.

• **واعْتَدِلْ فِي:** المقادير، فلا إفراط ولا تفريط، مصداقاً لقوله تعالى ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾.

الدليل: هذا النمط المتوازن تُشْهَدُ له مراجعات منهجية متعددة: الحبوب الكاملة تُخَفِّضُ خطرَ الوفاة القلبية، والبقوليات ترتبط بانخفاض الوفيات الكلية، وتقليلُ اللحوم المصنّعة والسكر والدهون المشبعة يرتبط بصحة قلبية أفضل. وهو في جوهره نمط قريب من الحمية المتوسطة المدروسة جيداً

قوة الدليل: قوي

الخلاصة العملية — ليس المطلوب أن نَسْتَبْدِلَ قائِمةَ «ممنوع ومسموح» بأخرى، بل أن نَمْلِكَ مَلَكَةَ الْوِزْنِ: نَأْكُلُ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَا اللَّهُ فِي اعتدال، ونُقَلِّلُ مما ثَبَتَ ضرره، وَلَا نُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ بهوى أو حدسٍ، وَلَا نَتَّبِعُ دعوى شفاءٍ بلا برهان. وبهذا يجتمعُ لنا خيرُ الميزانين: ميزانِ الوحي وميزانِ العلم.

الخلاصة

بدأنا هذا الكتاب بسؤال: ما الذي يقوله العلم والوحي — حقًا — عن «نظام الطيبات»؟ وخلصنا بعد وزنٍ متأنٍّ إلى أنَّ النظام، رغمَ ما في بعض مقاصده العامة من صواب، قد جانبَ المعنى القرآنيَّ للطيبات حين بنى سلطانه على التحريم، وجانبَ إجماع التغذية الحديثة حين حذفَ مجموعاتٍ نافعةٍ وأباحَ ما ثبتَ ضرره.

وأرجو أن يكون القارئ قد خرجَ لا بموقفٍ من شخصٍ، فقد تَرَحَّمنا على صاحب النظام وأوكلنا أمره إلى ربه؛ بل بمنهج في التعامل مع كلِّ دعوى صحية تُزفُّ إليه: أن يسألَ عن الدليل ومصدره، وأن يزنَ قوته، وألاَّ يحرمَ طيبًا أحله الله، وألاَّ يغترَّ بدعوى شفاءٍ لا برهانٍ عليها. فهذه الملكةُ خيرٌ من ألف قائمةٍ جاهزة.

وتبقى كلمةُ «الطيبات» — كما أرادها الله — بابَ سعةٍ ورحمةٍ لا بابَ ضيقٍ ومنعٍ؛ نأكلُ منها شاكرين، ونعتدلُ فيها غيرَ مُسرفين، ونحمدُ الله الذي جعلَ غذاءنا طيبًا وحلالًا. ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلمَ النافع، والقولَ السديد، والعملَ الرشيد.

وآخرُ دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

والله أعلم

المراجع العلمية (مصنفة)

أولاً: التفسيرُ القرآنيُّ وعلومُ القرآن

1. الطبري، محمد بن جرير. جامع البيان عن تأويل آي القرآن — تفسير قوله تعالى ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ (البقرة: 172).
2. القرطبي، محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن — تفسير آيات الطيبات والنهي عن التحريم (المائدة: 87؛ الأعراف: 32).
3. ابن كثير، إسماعيل بن عمر. تفسير القرآن العظيم — تفسير قوله تعالى ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ (طه: 81).
4. البغوي، الحسين بن مسعود. معالم التنزيل في تفسير القرآن — مادة الطيبات.
5. الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد. المفردات في غريب القرآن — مادة (طيب).
6. الإمام مسلم. صحيح مسلم — حديث «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا».

ثانياً: دراساتُ التغذية والأوبئة

1. Lane MM, et al. Ultra-processed food exposure and adverse health .BMJ .outcomes: umbrella review of epidemiological meta-analyses .e077310:384;2024
2. Marventano S, et al. Legume consumption and CVD risk: a systematic .review and meta-analysis Public Health Nutr / Nutr Metab .(PubMed PMID: 29230416) .Cardiovasc Dis
3. Schwingshackl L, et al. Food groups and risk of all-cause mortality: a .systematic review and meta-analysis of prospective studies

,Bechthold A, et al. Food groups and risk of coronary heart disease .4
.stroke and heart failure: dose-response meta-analysis (10 food groups)

ثالثاً: أمراض القلب والأيض والإرشادات الصحية

1. Dietary Fats and Cardiovascular Disease .American Heart Association .
— توصية الدهون المشبعة (أقل من 6% من السعرات).
2. Added Sugars and Cardiovascular .American Heart Association .
Disease
3. American Heart Association Scientific Sessions 2024 — بيانات أولية حول
الأكل المحصور في ثماني ساعات وخطر الوفاة القلبية.
4. Shmerling RH .Harvard Health Publishing — مقالات في الاعتدال الغذائي
بدل التحريم.

رابعاً: المراجعات المنهجية والصيام والترطيب

1. Systematic review (2019): Breakfast skipping and risk of .1
cardiovascular disease and all-cause mortality — (+21% CVD، +32%
الوفاة المبكرة).
2. Hydration guidance — Cindy Nelson (Utah State University .2
(Extension)؛ Jenna Morgan (Ohio State University) — في إشارة العطش
وقاعدة الأكواب الثمانية.

خامساً: مصادر إعلامية وبيانات مهنية

1. محمد صلاح. «نظام الطيّبات.. ماذا يقول العلم؟» — الجزيرة نت، 28 أبريل 2026م.
2. بيان النقابة العامة لأطباء مصر بشأن «نظام الطيّبات» وغياب الأدلة العلمية والتجارب
السريية المعتمدة.

The English Translation

The Tayyibat Diet on the Scale of Science
A Critical, Evidence-Based Evaluation in Light of the Qur'anic
Concept of Tayyibat

Introduction

Between a Noble Qur’anic Name and a Precise Scientific Scale

Rarely does a single topic gather what the “Tayyibat diet” has gathered: an awe-inspiring Qur’anic name evoking notions of lawfulness, purity, and blessing; a sweeping medical claim promising cures for chronic diseases that clinics and hospitals have struggled with; and an overwhelming spread across social media that turned lists of the “permitted” and the “forbidden” into something resembling a dietary creed for many. Then the sudden passing of the system’s author reignited the debate and returned the question to its root: what does science — truly, not by assertion — say about this system? And what does revelation say about the very word the system borrowed as its title?

This book is not a quarrel with a person, nor a victory of one school over another, nor a defense of any particular food industry. It is a disciplined attempt to weigh a popular dietary claim on two scales that admit no third for the inquiring Muslim: **the scale of revelation**, which sent down the word “Tayyibat” and clarified its intent, and **the scale of science**, which has accumulated decades of evidence on the

relationship between food and health. A claim that arrogates to itself support from both the Qur'an and medicine deserves to be weighed by both.

A striking paradox will emerge repeatedly throughout these chapters: the Qur'anic concept of Tayyibat is **inclusive, permissive, and facilitating** — commanding the eating of every lawful good thing and rebuking the zealots who forbid what God has permitted — while the popular “Tayyibat diet” inverts this meaning, building its authority on **prohibition**, even forbidding entire food groups that God Himself called Tayyibat in His Book. Between the name and the named lies a distance that reflection reveals and modern science only makes clearer.

I have arranged the book in eleven chapters: I begin by defining the system as its author presented it, without distortion, then I clarify the Qur'anic meaning of Tayyibat from authoritative exegesis, then I place before the reader a scientific “ruler” by which any diet may be weighed before being accepted. My method throughout is to attribute every scientific claim to its source and to grade the strength of the evidence according to evidence-based medicine; what is not established, I call unestablished, and I do not overreach into certainty that belongs to God alone.

Chapter One

What Is the “Tayyibat Diet”? Origin, Idea, and Rules

Before weighing anything, we must understand it fairly; treating an opponent justly before critiquing him is both scholarly trust and Islamic character. The system is attributed to the Egyptian physician Diyaa al-Din al-Awadi, and it spread widely through videos and posts on social media. On the nineteenth of April 2026 the author passed away — may God have mercy on him — at about forty-seven years of age, weeks after the Egyptian Medical Syndicate issued a decision striking off his membership, stating that the system “does not rest on accredited scientific evidence or clinical trials.”

I record two things: first, a person’s illness or death cannot by itself be taken as proof that his idea is false; prophets and the righteous fell ill and died, and illness is a decree that befalls the pious and the wicked alike. Second, the validity of a scientific claim is taken neither from praise nor blame of its author, but from bare evidence. So let us set aside the story of his passing and weigh the idea itself.

The Core Idea

At its heart the system divides foods sharply into two categories: foods it calls “tayyib” (good), described as “healing” because they are easy to digest and leave fewer “residues”; and foods it calls “khabith” (toxic/foul), claimed to cause inflammation and burden digestion, and so to be excluded entirely. This binary division is the cornerstone of the whole system, and the two words “tayyib” and “khabith” are Qur’anic terms with a defined meaning we will clarify in Chapter Two.

What It Permits and Forbids

The “permitted” list is surprisingly wide: it allows starches (whole-wheat bread, rice, potatoes), fats generously (butter, ghee, cream, corn and sunflower oils), aged cheeses, red meat, and sweets (basbousa, chocolate, Nutella, jam, sugar). The “forbidden” list deletes entire food groups: **milk and dairy**, **eggs** in every form, **poultry**, **legumes** (beans, lentils, chickpeas), **most vegetables** (cucumber, lettuce, arugula, carrot, tomato, spinach), and some fruits (watermelon, orange, cantaloupe).

A methodological note — It is striking that the system permits sugar, chocolate, basbousa, and saturated fats generously, while forbidding eggs, lentils, yogurt, broccoli, and spinach. This ordering is, as we shall see, inverted in many particulars from the consensus

of contemporary nutrition guidance and from what the Qur’anic meaning of “tayyib” requires.

The Source of the System’s Authority

The system was not first presented as a research hypothesis tested in controlled clinical trials, nor published in a peer-reviewed journal; it rested chiefly on **personal experience, theoretical inference, and followers’ testimonials**. This is a pivotal point, for the source of knowledge is the first thing asked when weighing a health claim: how did we come to know this is true?

Chapter Two

the Good and the — Tayyibat The Qur’anic Concept of Foul on the Scale of Revelation

Since the system borrowed a Qur’anic word for its title, justice requires returning the word to its revealed meaning. In the lexicon of al-Raghib al-Asfahani, al-tayyib is that which the senses and the soul find pleasant, and in the Law it denotes what is lawful and pure. The Qur’an commands eating of the good things and pairs the command with gratitude.

**O you who believe! Eat of the good“
things (tayyibat) that We have provided
”.you, and be grateful to God**

al-Baqarah: 172

The exegetes — al-Tabari, al-Qurtubi, Ibn Kathir, al-Baghawi — explain that the command to eat of the tayyibat carries a double rebuke: **a rebuke to the zealots (al-ghulat)** who abstain from and forbid the

good things God permitted, and **a rebuke to the excessive (al-jufat)** who do not restrain themselves to what is lawful and good. Thus the Qur'anic meaning sits in a balanced middle: wide permission with no prohibition by whim, and no excess.

**O you who believe! Do not forbid the“
good things that God has made lawful
”.for you, and do not transgress**

al-Ma'idah: 87

Here the Qur'an explicitly forbids prohibiting the good things, and counts such prohibition a form of transgression. The Prophet (peace be upon him) said, "God is good (tayyib) and accepts only what is good." So the revealed concept of tayyib is a gate of breadth and mercy, not of narrowness and prohibition — the very opposite of a system whose engine is forbidding.

Chapter Three

How Do We Weigh a Diet? Principles of Evidence-Based Medicine

Not every claim carries equal weight. Evidence-based medicine arranges evidence in a hierarchy: at the base lie personal anecdotes and testimonials (weakest), then observational studies, then randomized controlled trials, and at the summit systematic reviews and meta-analyses that pool dozens of studies (strongest). A single testimonial “I improved” is not proof, because of spontaneous improvement, the placebo effect, concurrent lifestyle changes, and publication bias.

I offer the reader a simple six-question “ruler” for any diet: (1) What is the source of the claim? (2) Is there controlled evidence, or only testimonials? (3) Does it agree with the broad consensus of nutrition science? (4) Does it forbid proven-beneficial foods? (5) Does it permit proven-harmful foods? (6) Does it make sweeping cure claims without trials? Throughout this book I grade evidence as **strong**, **moderate**, or **limited**, and where something is unproven I say so plainly.

Chapter Four

Legumes and Whole Grains — Deleting Pillars Science Has Proven Beneficial

The system forbids legumes (beans, lentils, chickpeas) and treats whole grains warily — yet these are among the foods nutrition science most consistently supports. Legumes are rich in plant protein, fiber, and minerals, and whole grains are linked to lower cardiovascular mortality.

Evidence: A meta-analysis of six cohorts (~219,000 participants) found legume consumption associated with a relative risk of all-cause mortality of about 0.93; the protection for cardiovascular mortality was modest and not always statistically significant — an honest reading. Separately, each additional 10 g/day of whole grains was associated with roughly a 4% reduction in cardiovascular mortality

Strength of evidence: strong (benefit/neutrality); the harm claimed by the system: none

The key point is this: forbidding legumes and whole grains has **no supporting evidence whatsoever**, while their benefit or neutrality is

well documented. Deleting them is therefore a clear departure from both the evidence and the Qur'anic command to eat of the good things.

✓ **In its favor:** Encouraging whole, minimally processed grains over refined ones is sound in principle

✗ **Against it:** Forbidding legumes contradicts evidence linking them to lower mortality

✗ **Against it:** No evidence supports treating these proven foods as harmful

Chapter Five

Eggs, Dairy, and Poultry — Groups Deleted Without Evidence

The system forbids eggs entirely, milk and dairy, and poultry. Yet eggs are a dense source of high-quality protein and nutrients; dairy provides calcium and protein; and skinless poultry is a lean protein recommended by heart-health guidance. Contemporary evidence does not support a blanket prohibition of any of these.

Evidence: Moderate egg consumption is not associated with increased cardiovascular risk in the general population in large bodies of evidence; dairy and lean poultry feature among the proteins recommended by major dietary guidelines. There is no controlled evidence justifying a total ban on these groups

Strength of evidence: the ban: unsupported

✓ In its favor: —

✘ **Against it:** Total prohibition of eggs, dairy, and poultry rests on no controlled evidence

✘ **Against it:** These groups are recommended sources of protein and nutrients in mainstream guidance

Chapter Six

Vegetables and Fruits — When the Most Beneficial Food Is Banned

Perhaps the strangest feature of the system is its forbidding of most vegetables (cucumber, lettuce, arugula, carrot, tomato, spinach) and some fruits. Vegetables and fruits are, by the consensus of nutrition science, among the most beneficial foods for health, rich in fiber, vitamins, and antioxidants, and linked to lower risk of chronic disease.

Evidence: Higher vegetable and fruit intake is consistently associated with lower cardiovascular and all-cause mortality across large meta-analyses. Banning them runs directly counter to one of the most robust findings in all of nutrition science

Strength of evidence: strong

✓ **In its favor:** Preferring cooked vegetables for some sensitive digestive cases can be reasonable individually

✘ **Against it:** A blanket ban on most vegetables and fruits contradicts the strongest evidence in nutrition

✘ **Against it:** It deprives the diet of fiber, micronutrients, and antioxidants

Chapter Seven

Fats and Calories — Unrestricted Permission Against Heart Guidance

The system permits fats generously — butter, ghee, cream — and abolishes any attention to caloric intake. While obsessive calorie counting is not necessary for everyone, unrestricted permission of saturated fats and sweets is a recipe for caloric surplus and weight gain for many.

Evidence: The American Heart Association recommends that saturated fat not exceed about 6% of daily calories — roughly 13 g/day for a 2,000-calorie intake. Unrestricted permission of fats, without regard to type or quantity, contradicts this recommendation

Strength of evidence: strong

The Heart Association emphasizes that what matters is the overall dietary pattern: whole grains, plant proteins, varied fruits and vegetables, less salt, sugar, animal fat, and processed food. Comparing this pattern with the “Tayyibat” pattern reveals contradiction in most particulars.

✓ **In its favor:** Attending to food quality, not only quantity, is sound in principle

✗ **Against it:** Generous permission of saturated fat conflicts with the <6% recommendation

✗ **Against it:** Abolishing energy awareness alongside permitted sweets may cause caloric surplus

Chapter Eight

Water, Thirst, and Intermittent Fasting — Rules That Need Qualification

The system advises “drink only when thirsty” and “adopt intermittent fasting.” Neither is wholly wrong, but both need qualification absent from the system’s general presentation. Hydration experts note that relying on thirst alone may come late: thirst is an alarm signaling mild dehydration that may not appear until more than 1.5 liters have been lost. The simplified “about eight cups a day” remains a practical reference, adjusted for activity, climate, and health.

Evidence: A 2019 systematic review found that those who regularly skipped breakfast had a 21% higher risk of cardiovascular disease and a 32% higher risk of early death. Preliminary 2024 data presented at an American Heart Association meeting linked restricting eating to an 8-hour window with higher cardiovascular death risk — preliminary findings needing confirmation

Strength of evidence: limited to moderate

A fair reading does not negate all forms of timed eating, but reminds us that intermittent fasting is not “automatically safe” for everyone — the

pregnant, diabetics, those on certain medications — and that generalizing it without individual consideration may harm. The governing principle is detail and medical consultation, not blanket rules.

Chapter Nine

Ultra-Processed Foods and Sugar — Where the System Partly Meets Science

Fairness requires noting where the system is right. In discouraging industrial, ready-made foods and encouraging fresh home cooking, it meets a firm trend in nutrition science. Ultra-processed foods — laden with sugars, hydrogenated fats, salt, and additives — are a growing scientific concern.

Evidence: A major umbrella review in the BMJ (2024), pooling evidence from about ten million participants, linked greater ultra-processed food intake with thirty-two adverse health outcomes, including cardiovascular disease, type 2 diabetes, depression, and early death

Strength of evidence: strong

Yet the great paradox is that the system — while warning against the “foul” — permits white sugar, chocolate, Nutella, jam, basbousa, and canned juices. Added sugar and sweets are at the very core of what nutrition guidance warns against. How can one fight the processed while permitting concentrated sugar? The flaw is in the system’s criterion: it classified food by a vague subjective measure (“ease of

digestion”) rather than by documented health effect, and so forbade lentils, yogurt, and eggs while permitting sugar and chocolate.

✓ **In its favor:** Encouraging fresh, home-prepared food and shunning ready-made processed food agrees with science

✗ **Against it:** Permitting sugar, chocolate, jam, and basbousa undercuts this very aim

✗ **Against it:** The subjective criterion fails to distinguish harmful from beneficial as health evidence does

Chapter Ten

The Claim of Curing Chronic Disease — Where Is the ?Evidence

The gravest element of the system is not its food lists but its sweeping claim to cure or prevent chronic diseases — diabetes, heart disease, autoimmune conditions. A claim of this magnitude demands the highest scrutiny, for a firm rule of science holds: **extraordinary claims require extraordinary evidence**. The burden of proof lies on the claimant, and acceptable proof is not followers' testimonials, which do not rise to evidence because of spontaneous improvement, the placebo effect, concurrent habit changes, and publication bias.

Scientific position: As of this book's writing, there are no controlled clinical trials published in peer-reviewed journals proving that this particular system cures any chronic disease. A medical claim without controlled trials remains an unproven hypothesis, however many individual testimonials accumulate

Strength of evidence: claim unsupported by evidence

The Egyptian Medical Syndicate stated that the system does not rest on accredited scientific evidence or clinical trials; whatever one's view of

the circumstances, the core scientific observation stands: the absence of published, peer-reviewed evidence. A real practical danger must also be flagged — that a diabetic or cardiac patient might abandon prescribed treatment trusting a diet that promises a cure. Balanced nutrition is part of managing chronic disease, not a substitute for medical treatment.

✓ **In its favor:** Recalling the role of diet in preventing chronic disease is sound in general

✗ **Against it:** Claiming to “cure” chronic disease without controlled trials is unproven

✗ **Against it:** Individual testimonials cannot substitute for evidence

✗ **Against it:** Replacing medical treatment with the system poses real risk

Chapter Eleven

The Verdict of the Scale — Toward a Balanced Dietary Pattern

In one sentence: the “Tayyibat diet” borrowed a noble Qur’anic name, set out from personal intuition rather than research method, was right in some general aims (shunning processed food, favoring fresh food, not obsessing over calories), and wrong in many applications (forbidding beneficial food groups without evidence, generously permitting sugar and saturated fat, and the sweeping cure claim). On the scale of revelation it inverted the meaning of “Tayyibat” from permission to prohibition; on the scale of science it contradicted, in most particulars, the consensus of nutrition guidance.

**Do not forbid the good things that“
God has made lawful for you, and do
”.not transgress**

al-Ma'idah: 87

It is remarkable that a system titled “Tayyibat” should make its essence the forbidding of many tayyibat. The balanced alternative — attested by both revelation and science — is this: **eat more** whole grains, legumes, varied vegetables and fruits, lean proteins (fish, skinless poultry, eggs), moderate dairy, nuts, and healthy oils like olive oil; **eat less** added sugar and sweets, saturated fat (under 6% of calories), salt, processed meats, and ultra-processed foods; and **be moderate** in portions — “Eat and drink, but do not be excessive.”

Evidence: This balanced pattern — close to the well-studied Mediterranean diet — is supported by multiple meta-analyses: whole grains lower cardiac mortality, legumes are linked to lower all-cause mortality, and reducing processed meat, sugar, and saturated fat is associated with better cardiovascular health

Strength of evidence: strong

The practical conclusion — The goal is not to swap one “forbidden/permitted” list for another, but to acquire **the faculty of weighing**: eat of the good things God provides, in moderation; reduce what is proven harmful; do not forbid what God permitted by whim; and do not follow a cure claim without proof. Thus we gain the best of both scales.

Conclusion

We began with a question: what do science and revelation truly say about the “Tayyibat diet”? After careful weighing we concluded that the system, despite some sound general aims, departed from the Qur’anic meaning of Tayyibat when it built its authority on prohibition, and departed from the consensus of modern nutrition when it deleted beneficial groups and permitted what is proven harmful.

I hope the reader leaves not with a stance toward a person — for we have asked God’s mercy upon the system’s author and entrusted his affair to his Lord — but with a method for dealing with every health claim presented to him: to ask for the evidence and its source, to weigh its strength, never to forbid a good thing God has made lawful, and never to be deceived by a cure claim without proof. This faculty is better than a thousand ready-made lists.

The word “Tayyibat,” as God intended it, remains a gate of breadth and mercy, not of narrowness and prohibition; we eat of it thankfully, are moderate without excess, and praise God who made our food good and lawful.

And our final prayer is that all praise belongs to God, Lord of the worlds.

And God knows best.

References (Categorized)

I. Qur'anic Exegesis

1. Al-Tabari. Jami' al-Bayan — commentary on al-Baqarah: 172.
2. Al-Qurtubi. Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an — al-Ma'idah: 87; al-A'raf: 32.
3. Ibn Kathir. Tafsir al-Qur'an al-'Azim — Taha: 81.
4. Al-Baghawi. Ma'alim al-Tanzil.
5. Al-Raghib al-Asfahani. Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an — entry (t-y-b).
6. Sahih Muslim — “God is good and accepts only what is good.”

II. Nutrition and Epidemiology

1. Lane MM, et al. Ultra-processed food and adverse health outcomes: umbrella review. BMJ. 2024;384:e077310.
2. Marventano S, et al. Legume consumption and CVD risk: meta-analysis. PMID: 29230416.
3. Schwingshackl L, et al. Food groups and all-cause mortality: systematic review and meta-analysis.
4. Bechthold A, et al. Food groups and risk of CHD, stroke, heart failure: dose-response meta-analysis.

III. Cardiovascular, Metabolic, and Health Guidance

1. American Heart Association. Dietary Fats and Cardiovascular Disease (saturated fat <6% of calories).
2. American Heart Association. Added Sugars and Cardiovascular Disease.
3. AHA Scientific Sessions 2024 — preliminary data on 8-hour time-restricted eating.
4. Shmerling RH, Harvard Health Publishing — moderation over prohibition.

IV. Systematic Reviews, Fasting, and Hydration

1. Systematic review (2019): breakfast skipping and CVD/all-cause mortality (+21% CVD; +32% early death).
2. Hydration guidance — Cindy Nelson (Utah State University Extension); Jenna Morgan (Ohio State University).

V. Media and Professional Statements

1. Muhammad Salah. “The Tayyibat Diet: What Does Science Say?” Al Jazeera Net, 28 April 2026.
2. Statement of the Egyptian Medical Syndicate regarding the absence of scientific evidence and clinical trials.

About the Author — نبذة عن المؤلف

د. فضل محمد الأكوع

باحثٌ يمنيٌّ، يعملُ في شُعبةِ أمراضِ الكلى بجامعة ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية. له اهتمامٌ واسعٌ يجمعُ بين البحثِ العلميِّ الأكاديميِّ والتأليفِ في حقولٍ متعددةٍ تشملُ الدراساتِ الإسلامية، والشأنَ اليمنيَّ والإقليميَّ، والعلومَ والطبَّ، والتقنيةَ الحديثة. يُعنى في كتاباته بالجمع بين المرجعية الشرعية المنضبطة والمنهج العلميِّ المبني على البراهين، ساعياً إلى تقديم معرفةٍ موثقةٍ تنفعُ القارئَ العربيَّ في قضايا عصره.

Dr. Fadhl Mohamed Alakwaa

A Yemeni researcher in the Division of Nephrology at the University of Michigan, USA. His interests bridge academic scientific research and authorship across multiple fields — Islamic studies, Yemeni and regional affairs, science and medicine, and modern technology. In his writing he seeks to combine disciplined religious scholarship with an evidence-based scientific method, offering well-documented knowledge that serves the Arab reader on the questions of the age.

Publications — مؤلفات المؤلف

1. نهاية الكون في القرآن الكريم — تحليل علمي شامل (2026م).
 2. نظام الطيّبات في ميزان العلم — قراءة علمية نقدية في ضوء الطب المبني على البراهين والمفهوم القرآني للطّيّبات (2026م).
1. The End of the Universe in the Holy Qur'an: A Comprehensive Scientific Analysis (2026).
 2. The Tayyibat Diet on the Scale of Science: A Critical, Evidence-Based Evaluation (2026).



عن الكتاب

انتشر «نظام الطيبات» الغذائي على نطاق واسع مستعيرا اسما قرآنيا كريما، فقسم الأطعمة إلى «طيبة» و«خبثة سامة»، ومنع مجموعات غذائية كاملة كالبقوليات والبيض والألبان ومعظم الخضراوات. يزن هذا الكتاب النظام في ميزانين: المفهوم القرآني الجامع للطيبات، والطب الحديث المبني على البراهين، فبين ما له وما عليه بإنصاف، ويقترح بديلا متوازنا تشهد له النصوص والدراسات معاً.

عن المؤلف

د. فضل محمد الأكوع، باحث يمني في قسم أمراض الكلى بجامعة ميشيغان، وكاتب في الدراسات الإسلامية والعلوم الطبية والتقنية. يجمع في مؤلفاته بين دقة المنهج العلمي وروح المرجعية الشرعية.